

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTE POLE MERE-FEMME	DECLenchement ARTIFICIEL DU TRAVAIL		090 PMF 210 PTXX 011
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FOETALES	Version 2 Page 1 / 9

1 – Concerne : les médecins obstétriciens, sages-femmes et internes de gynécologie obstétrique des unités de salles de naissances et pathologies materno-fœtales (PMF).

2 – Application :

Toute décision de déclenchement artificiel du travail sera prise par le staff obstétrical ou le médecin senior de garde.

A. Indications :

- Déclenchement artificiel du travail à membranes intactes ou rompues.
- Age gestationnel ≥ 34 SA
- Absence de contre-indication à un accouchement voie basse

B. Modalités de déclenchement artificiel du travail :

Information de la patiente des modalités de déclenchement et recueil de son consentement – remise de la note d'information destinée aux patientes (cf annexe1)

■ **Col non favorable (Score de Bishop < 6) et utérus non cicatriciel ≥ 35 SA :**

→ Maturation cervicale par misoprostol (Angusta®) + Ballonnet intracervical

L'association de ces 2 méthodes permet de réduire la durée totale du déclenchement

En cas de refus de la patiente : l'utilisation d'une seule des 2 méthodes est également possible

■ **Col non favorable (Score de Bishop < 6) et utérus uni-cicatriciel, ou grossesse gémellaire, ou grossesse singleton < 35 SA :**

→ Maturation cervicale par Ballonnet intracervical

■ **Col favorable (Score de Bishop ≥ 6) ou après 24 heures de maturation cervicale :**

→ Déclenchement artificiel du travail par RAPDE si possible, PSE ocytocine +/- analgésie péridurale

Intitulé et référence du document associé : aucun			
REDACTION : Dr Astrid ECKMAN LAGROIX Gynécologue obstétricien	VERIFICATION : Mohcine AICH Qualiticien - DAJPAQ	VALIDATION : Dr LUCOT ROYER	APPROBATION : Pr Nicolas MOTTET Gynécologue obstétricien
Liste de diffusion :			
Relecture périodique du document - sans modification par :			

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ POLE MERE-FEMME	DECLenchement ARTIFICIEL DU TRAVAIL		090 PMF 210 PTXX 011 Version 2 Page 2 / 9
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FOETALES	

1) **Misoprostol (Angusta®)**

Prescription par le gynécologue obstétricien ou l'interne de gynécologie obstétrique dans le logiciel informatique de prescription médical

Angusta® 25 microgrammes par voie orale : **1 comprimés toutes les 2 heures sans dépasser la dose de 8 comprimés par 24 heures** (200 microgrammes par 24 heures)

Poursuite du déclenchement par Ocytocine possible 4 heures après la prise des derniers comprimés.

a) **Contre-indications au Misoprostol :**

- Travail spontané
- Utérus cicatriciel
- Malformation utérine connue contre indiquant l'accouchement voie basse
- Anomalies sévères du RCF
- Placenta prævia recouvrant
- Saignement vaginal inexpliqué
- En cas d'anomalie de présentation du fœtus, contre-indiquant un accouchement par voie basse.
- Insuffisance rénale sévère avec DFG < 15ml/min
- Age gestationnel < 35 SA
- Grossesse multiple

b) **Précautions d'emploi**

- Posologies à adapter en cas d'insuffisance rénale ou hépatique maternelle
- L'allaitement maternel est possible 4 heures après la prise des derniers comprimés

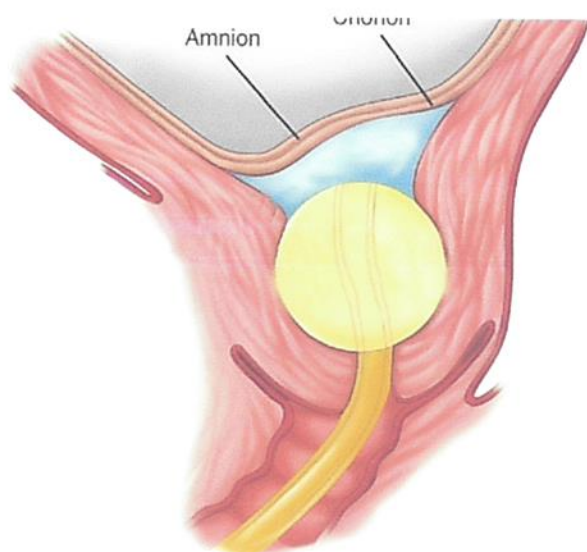
c) **Effets indésirables :**

- Nausées, vomissements
- Diarrhées
- Hémorragie du post-partum

2) **Ballonnet intracervical**

- Utilisation d'une sonde de Foley CH18
- Ballonnet à gonfler avec 30 à 60mL d'eau PPI, à placer au-dessus de l'OI
- Proposer le protoxyde d'azote si besoin
- Vérification du bon positionnement du ballonnet en fin de geste par TV, puis fixer la sonde à la face interne de la cuisse pour permettre à la patiente de se mobiliser sans difficulté

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTE POLE MERE-FEMME	DECLenchement ARTIFICIEL DU TRAVAIL PROTOCOLE PATHOLOGIES MATERNELLES ET FOETALES	090 PMF 210 PTXX 011 Version 2 Page 3 / 9
--	---	--



Source: F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Catherine Y. Spong, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Joanne S. Sheffield: *Williams Obstetrics*, 25th Edition
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

3) Modalités pratiques de la maturation cervicale

La maturation cervicale sera initiée en salle de naissances.

Elle peut se réaliser dans les services de pathologies maternelles et fœtales et/ou urgences gynécologiques sur accord du staff ou du gynécologue obstétricien de garde

- Patiente perfusée avec une voie veineuse périphérique de bon calibre.
- Bilan préopératoire disponible (Numération globulaire, bilan de coagulation, RAI et carte de groupe sanguin valide).
- Consultation pré anesthésique faite.
- Tocolyse d'urgence par Terbutaline (Bricanyl®) à disposition dans le box ou la chambre :
 - 1 plateau avec 1 seringue de 10ml, 1 trocart rose, 1 ampoule de Terbutaline (Bricanyl®) 0,5mg/ml, 1 ampoule de 20 ml de NaCl 0.9 % injectable, 1 bouchon.

Rappel de préparation : dans une seringue de 10ml : 1 ampoule de Terbutaline (Bricanyl®) 0,5mg/ml + 9ml de NaCl 0.9% ; injecter en IVD la moitié de la solution obtenue soit 5ml.

- Enregistrement du rythme cardiaque fœtal pendant **30 minutes avant** la prise des médicaments et/ou la pose du ballonnet

 CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ POLE MERE-FEMME	DECLenchement ARTIFICIEL DU TRAVAIL		090 PMF 210 PTXX 011
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FOETALES	Version 2 Page 4 / 9

- Administration des médicaments par la sage-femme qui en effectue la traçabilité dans le logiciel informatique et/ou pose du ballonnet par IDG ou MDG
- Poursuite de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal **pendant 45 minutes.**
- Dans l'unité de PMF, contrôle du rythme cardiaque fœtal
 - 8 heures après la 1^{ère} prise de Misoprostol (soit lors de la 5^{ème} prise) et/ou pose de ballonnet
 - En cas de manifestations cliniques (contractions utérines douloureuses, rupture des membranes, métrorragies etc ...)
 - En cas d'absence de manifestations cliniques prévoir un contrôle entre 22h et 23h00.
 - En l'absence de manifestations cliniques : entre 8 heures et 10 heures du matin le lendemain du début de la prise en charge et **maximum 12h après le dernier ERCF**

4) **Déclenchement du travail par RAPDE / ocytocine / APD**

- En l'absence de contre-indication, une pose d'analgésie péridurale doit être proposée à la patiente. Elle n'est pas obligatoire, et est à évaluer au cas par cas et selon le risque obstétrical sous-jacent.
- Patiente perfusée avec une voie veineuse périphérique de bon calibre.
- Bilan préopératoire disponible (Numération globulaire, bilan de coagulation, RAI et carte de groupe sanguin valide).
- Consultation pré anesthésique faite
- Tocolyse d'urgence par Terbutaline (Bricanyl®) à disposition dans le box ou la chambre :
 - ➔ 1 plateau avec 1 seringue de 10ml, 1 trocart rose, 1 ampoule de Terbutaline (Bricanyl®) 0,5mg/ml, 1 ampoule de 20 ml de NaCl 0.9 % injectable, 1 bouchon.

Rappel de préparation : dans une seringue de 10ml : 1 ampoule de Terbutaline (Bricanyl®) 0,5mg/ml + 9ml de NaCl 0.9% ; injecter en IVD la moitié de la solution obtenue soit 5ml.

- En cas de présentation céphalique appliquée et PDE accessible : privilégier une rupture artificielle de la PDE en première intention, sinon RAPDE dès que possible
- En cas de présentation du siège ou PDE non accessible ou après RAPDE : débiter PSE Ocytocine

 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MERE-FEMME	DECLenchement ARTIFICIEL DU TRAVAIL		090 PMF 210 PTXX 011
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FOETALES	Version 2 Page 5 / 9

a) Préparation et administration PSE Ocytocine

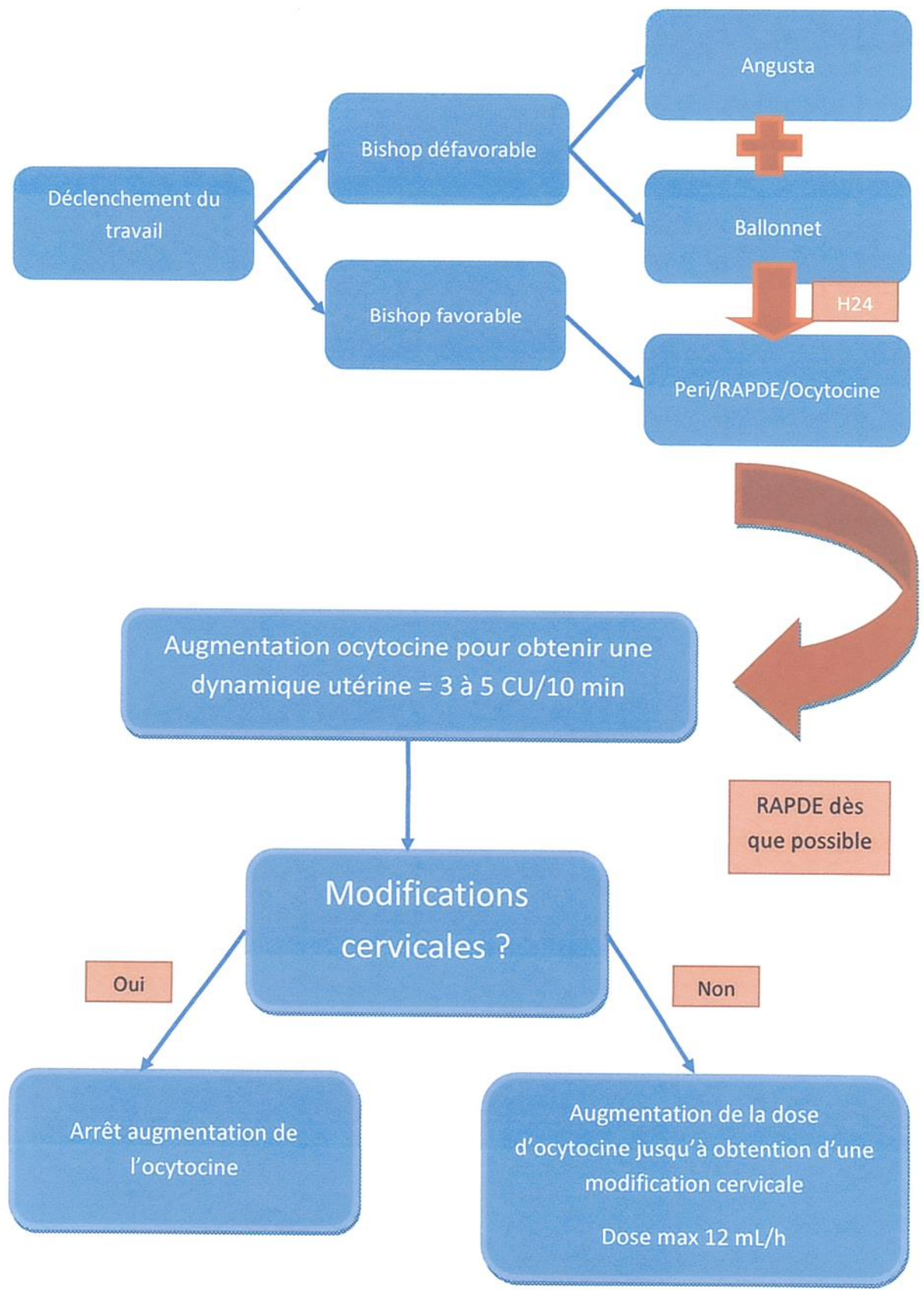
- Dans une seringue de 50mL : mettre 1 ampoule de 5 UI d'ocytocine dans 49 mL de de sérum glucosé isotonique G5% ou de chlorure de sodium à 0,9 %
- Début de perfusion à la vitesse 1,2 ml/h (V1.2mL/h)
- **Augmentation progressive de la dose par palier de 30 minutes jusqu'à obtention d'une dynamique utérine correcte (3 à 5 Contractions utérines par 10 minutes)**
- Dose maximale 12 ml/h (V12 mL/h)
- Nombre maximal d'ampoule d'ocytocine utilisable pour le déclenchement : 5 ampoules

b) Modalités de surveillance

- ERCF en continu avec tocométrie de bonne qualité (tocométrie interne si besoin)
- Réévaluation cervicale dans les 2 heures maximum suivant l'obtention d'une dynamique utérine correcte :
- En l'absence de modification cervicale : augmenter la vitesse du PSE d'ocytocine jusqu'à l'obtention d'une modification cervicale (surveillance horaire) ou jusqu'à 12 ml/h maximum (V12 mL/h)
- Si modifications cervicales : maintien de la dose à l'identique. Une diminution voire un arrêt du PSE d'ocytocine pourra être envisagé une fois la patiente en phase active du travail sous couvert du maintien d'une dynamique utérine correcte.
- **En cas d'utérus cicatriciel : il convient de ne pas dépasser la dose de 6ml/h (V6 mL/h)**

c) Définition de l'échec du déclenchement

On parlera d'échec du déclenchement (en l'absence d'anomalie sévère du RCF) si la patiente n'a pas atteint 5 cm de dilatation cervicale dans les 12 heures qui suivent l'obtention d'une bonne dynamique utérine sous PSE d'ocytocine à dose maximale, avec membranes rompues.

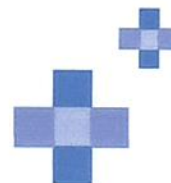


 CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ POLE MERE-FEMME	DECLenchement ARTIFICIEL DU TRAVAIL		090 PMF 210 PTXX 011 Version 2 Page 7 / 9
	PROTOCOLE	PATHOLOGIES MATERNELLES ET FOETALES	

Références

- American College of Obstetricians and Gynecologists (College); Society for Maternal-Fetal Medicine, Caughey AB, Cahill AG, Guise JM, Rouse DJ. Safe prevention of the primary cesarean delivery. *Am J Obstet Gynecol.* 2014;210:179-193
- Recommandations HAS 2008 : déclenchement artificiel du travail à partir de 37 SA
- Recommandations HAS 2018 : accouchement normal, accompagnement de la physiologie et interventions médicales
- ACOG 2019 : vaginal birth after cesarean delivery
- AJOG 2024 : methods for the induction of labor : efficacy and safety
- Foley catheter (80 vs 60 mL) and misoprostol for labor induction in nulliparous women: a randomized controlled trial. Chanderdeep Sharma, Sakshi Jaryal, Anjali Soni *Am J Obstet Gynecol.* 2023 Aug
- Comparison of balloon catheter and oral misoprostol for cervical ripening in women with pre-labor rupture of membranes: A Finnish randomized controlled trial, Heidi Krut, Leena Rahkonen, *Acta Obstet Gynecol Scand* 2025
- Labor induction with a combined method (pharmacologic and mechanical) A randomized controlled trial. Polónia-Valente R, et al. *Gynecol Obstet Hum Reprod.* 2023

Annexe 1 : Fiche information patiente



Note d'information destinée aux femmes enceintes

LE DÉCLenchement ARTIFICIEL DU TRAVAIL

Madame,
Un déclenchement artificiel du travail est envisagé pour votre accouchement à la suite d'une discussion médicale. Cette fiche d'information a pour objectif de vous permettre de prendre une décision éclairée concernant la méthode de déclenchement qui vous est proposée.

Qu'est-ce qu'un déclenchement ?

Le déclenchement artificiel du travail consiste à provoquer des contractions de l'utérus pour faire débuter le travail, c'est-à-dire le processus qui aboutit à l'accouchement.

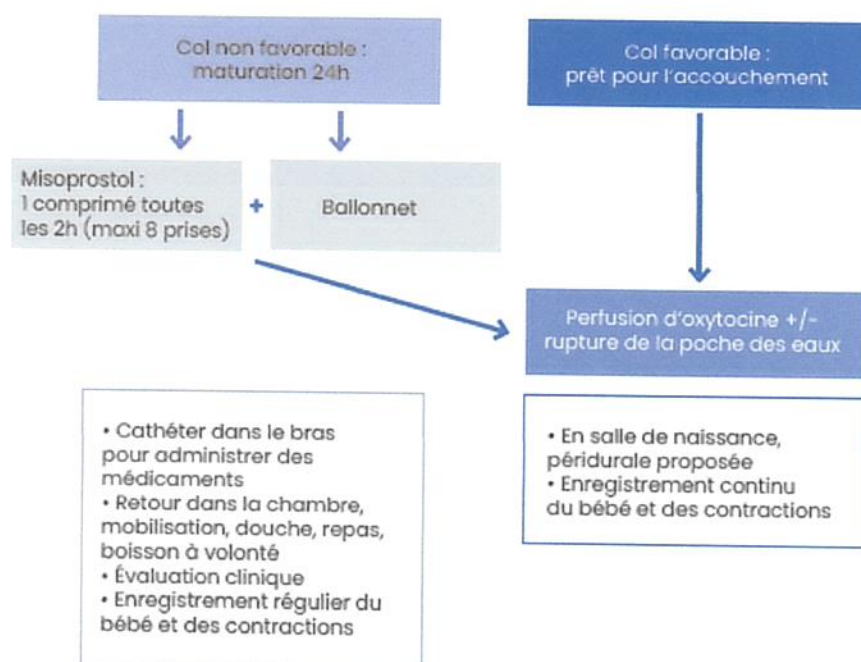
Il concerne aujourd'hui en France et au CHU de Besançon 1 patiente sur 4. L'objectif est de permettre une naissance par voie naturelle dans les meilleures conditions de sécurité pour vous et votre bébé.

Le délai entre
le début du
déclenchement
et la naissance de
votre bébé peut
prendre plusieurs
jours

Les indications et modalités de déclenchement

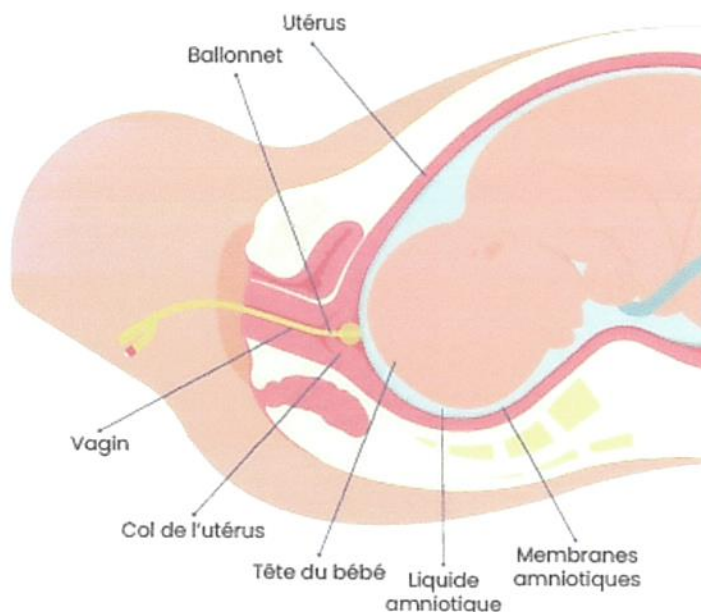
Les indications sont variées. Dans la majorité des cas, hors urgence, la décision est proposée par une équipe composée de plusieurs médecins et sages-femmes.
Les modalités de déclenchement diffèrent selon l'état du col de l'utérus et l'histoire médicale de chaque femme.

On distingue deux situations : une maturation du col puis une perfusion ou une perfusion d'emblée si le col est déjà suffisamment modifié.



Le ballonnet

- Le ballon est placé au niveau du col pour le mettre en tension
- Il est mis en place sous spéculum, sans anesthésie, puis gonflé avec de l'eau (30 à 60 ml)
- La sonde en place est fixée à la cuisse ; cela permet de se mobiliser, d'uriner ou d'aller à la selle sans difficulté
- Le ballonnet peut rester en place 24h
- Il sera utilisé seul en cas de cicatrice utérine (césarienne ou myomectomie)



Le Misoprostol (Angusta®)

Le traitement consiste en une prise orale de médicaments appartenant à la classe des prostaglandines appelés misoprostol (Angusta®) à hauteur de 1 comprimé toutes les 2 heures (maximum 8 prises).

L'association de ces 2 méthodes (médicaments + ballonnet) permet de réduire la durée totale du déclenchement et vous sera proposée en 1^{re} intention. Cependant vous avez le droit de refuser l'une de ces 2 méthodes, votre choix sera bien sûr respecté.

Les méthodes de déclenchement peuvent entraîner des contractions d'intensité variable et différents moyens vous seront proposés pour soulager la douleur en fonction de vos besoins.

Comme pour tout accouchement, il existe un risque de césarienne mais ce risque ne semble pas augmenter en cas de déclenchement et reste contrôlé dans notre équipe (entre 12 et 15 %). La césarienne peut être décidée en cas d'échec des méthodes de déclenchement ou en cas de nécessité pour vous ou votre enfant.

Points à retenir

- Il s'agit d'une décision partagée entre vous et l'équipe médicale
- La surveillance est rapprochée pour garantir votre sécurité et celle de votre bébé
- La date et l'heure du début du déclenchement du travail peut être différée en fonction de l'organisation du service et de l'occupation de la salle de naissance
- Une personne de votre choix pourra vous accompagner pour toutes les étapes du déclenchement
- Votre consentement est demandé à chaque étape



L'ensemble de l'équipe se tient à votre disposition, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à tout moment.

Retrouvez cette information sur le site du CHU de Besançon

